

13 - FMPP MOOCs - Les spondyloarthrites - Rhumatologie - Pr. El Bouchti

Bonjour, nous avons abordé le chapitre des spondyloarthrites. Les objectifs de ce cours, c'est de connaître les différentes spondyloarthrites et leurs manifestations communes, définir les manifestations axiales, articulaires, périphériques, enthésopathiques et extra-articulaires, connaître les signes radiologiques, connaître les principes de traitement et de suivi de la maladie. Voici le plan qu'on va suivre.

Les spondyloarthrites sont un groupe de rhumatisme inflammatoire chronique qui est caractérisé par une atteinte axiale, atteinte articulaire périphérique, atteinte de l'enthèse, des manifestations extra-articulaires qui survient sur un terrain génétique commun attesté par la présence de l'HLA-B27. Les entités cliniques regroupées sur le terme de spondyloarthrite sont la spondyloarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le sarfocytrome, les spondyloarthrites à début juvénile et les formes indifférentes. Une nouvelle terminologie a été proposée et nous avons trois formes, la spondyloarthrite axiale, radiographique et non radiographique, la spondyloarthrite périphérique articulaire, érosive et non érosive et les spondyloarthrites périphériques anthésiques.

Pour chaque type, on va rajouter les éventuelles manifestations extra-articulaires concomitantes, tels qu'un psoriasis, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, oeuillite ou autre. Par exemple, si nous avons une spondyloarthrite axiale non radiographique avec oeuillite ou spondyloarthrite périphérique érosive avec psoriasis. Sur le plan épidémiologique, il existe une prédominance masculine.

D'ailleurs, on retrouve trois hommes pour une femme qui sont malades. C'est une population qui est jeune, entre 20 et 30 ans. La prévalence de l'HLA-B27 diffère en fonction de l'entité.

Par exemple, ça va jusqu'à 95 % dans la spondyloarthrite antérieure et 50 % dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. L'HLA-B27 n'est retrouvé que dans 4 à 8 % de la population générale. La physiopathologie reste encore mal connue malgré la progression rapide de connaissances et il est reconnu que la lésion caractéristique est l'enthésopète.

En effet, il s'agit d'une atteinte inflammatoire, de l'insertion osseuse, d'un tendon, d'un ligament, d'une capsule et cette inflammation évolue vers l'ossification. Les hypothèses actuelles intègrent trois facteurs de susceptibilité. Premièrement, les facteurs génétiques et donc l'HLA-B27.

Le poids des facteurs génétiques intervient pour probablement 90 % dans le risque de développer une spondyloarthrite. S'ajoutent aussi les facteurs de l'environnement. Le rôle des infections, notamment par exemple l'arthrite réactionnelle qui se développe après des infections génitales et digestives.

Deuxièmement, le rôle du microbiote intestinal. Nous avons une altération de l'équilibre. C'est une dysbiose caractérisée par la raréfaction des bactéries aux propriétés anti-inflammatoires.

Le tabagisme joue un rôle néfaste que ce soit dans le développement de la maladie et dans son activité et sa progression structurelle. Troisième facteur, la réponse humide particulière. On assiste à une activation importante de la voie des interleuquines 23 et 17.

Ce qui va engendrer une production excessive de cytokines pro-inflammatoires tels que l'interleuquine 23, l'interleuquine 17, le TNF-alpha, l'IL-6 et le TGF-bêta. Ces cytokines sont des cibles thérapeutiques potentielles. Sur le plan anatomopathologique, l'anthésopathie inflammatoire évolue en trois phases.

Une phase inflammatoire initiale qui se traduit par des érosions osseuses. Une phase de fibroses cicatricielles et puis une phase d'ossification qui peut s'étendre dans le ligament ou le tendon, se forme d'anthésophites ou au niveau du périoste, donnant l'aspect de la position périostée. L'asthénovite que l'on retrouve dans les spondyloarthrites serait probablement secondaire à l'anthésopathie qui est à côté de l'asthénovial articulaire.

Le diagnostic positif, on va voir le terrain, la clinique commune au spondyloarthrite, puis on va voir la biologie et l'hématurgie. Le terrain, c'est souvent un homme jeune, moins de 45 ans, pour voir ce qu'il est tabagique, s'il n'y a pas de cas familiaux dans la famille. La symptomatologie commune est faite d'un syndrome pélvien, d'un syndrome rachidien, d'un syndrome anthésique, syndrome articulaire périphérique et syndrome extra-articulaire.

Ces différents syndromes se manifestent de façon variable d'un sujet à l'autre. Le syndrome pélvien, c'est une atteinte des sacroiliacs. Les signes fonctionnels, ce sont des douleurs inflammatoires des fesses, qu'on appelle fessalgies.

Ces fessalgies peuvent être bilatérales, unilatérales ou à bascule. Elles peuvent irradier à la face postérieure de la cuisse, donnant un aspect de pseudo-scientifique. L'examen clinique des sacroiliacs contient plusieurs manœuvres, notamment le patric-test, le signe du trépied et la pression directe.

L'atteinte rachidienne débute classiquement au rachis lombaire, s'étendant secondairement au rachis thoracique et plus tard au rachis cervical. La douleur est classiquement de type inflammatoire. Quelles sont les caractéristiques d'une rachialgie inflammatoire suspecte d'une spondylarthrite? Il faut au moins 4 critères sur 5. Notamment, un âge de début de rachialgie avant 40 ans.

Un début insidieux. L'amélioration des douleurs à l'exercice. Une absence d'amélioration au repos.

Des douleurs nocturnes. L'examen physique tend à mettre en évidence l'arrêt d'heure

rachidienne. Il se traduit au niveau lombaire par une augmentation dans la distance toit seul et un indice de chou vert qui est moins de 10,4 cm.

Au niveau dorsal, on trouvera une syphose dorsale qui est accentuée. Une ampliation thoracique est limitée. La respiration abdominale qui prend la relève par atteinte de la cage thoracique, par atteinte des articulations sternocostales et de l'articulation manubrio-sternale.

Au niveau du rachis cervical, on assiste à une augmentation de distance nuque-mûre, occipite-mûre, montant-sternum. Et à la langue, on va assister à une attitude guindée de la tête avec perdu retard horizontal comme on voit sur la photo. Maintenant, l'atteinte anthésopathique périphérique.

L'anthésite. Toutes les anthèses peuvent être touchées avec une préférence pour les membres inférieurs. Parmi les anthésites, la thalaspie est la plus fréquente et la plus caractéristique de la maladie.

En effet, c'est une thalaspie d'horaire inflammatoire. Ce n'est pas une douleur qui va réveiller le malade la nuit, mais beaucoup plus au matin, au lever, lors du premier pas. Et c'est une douleur qui s'améliore au cours de la journée.

Chez un sujet jeune, avec une thalaspie bélatérale ou à bascule, il faut évoquer le diagnostic de spondyloarthrie. La thalaspie peut être inférieure par une atteinte de la ponévrose plantaire, donc une aponevrosie plantaire inférieure, comme elle peut être postérieure par une atteinte du tendon calcanien, ou bien sûr, ou les deux. Les autres localisations des anthésopathies.

Au niveau du genou, c'est le tendon rotulien, la tubérosité tibiale antérieure, le grand trochanter, la paroi thoracique antérieure. Au niveau du bassin, on peut avoir une atteinte des crêtes iliaques, qui donnera un aspect de bassin hérissé à la radiographie standard, et puis des anthésopathies ischiatiques. Concernant la dactylite.

La dactylite, elle donne un aspect en saucisse des orteils ou des doigts. Il s'agit d'une tumefaction globale de l'orteil ou du doigt, en rapport avec l'association des anthésopathies inflammatoires, distales, et l'arthrite, le plus souvent tripolaire, au niveau des trois étages. Concernant le syndrome articulaire périphérique, il se voit dans 20 à 35 % des cas.

Toutes les articulations peuvent être touchées, mais il faut savoir que c'est une atteinte beaucoup plus fréquemment retrouvée au niveau des membres inférieurs. Il s'agit d'une oligoarthrite dans la majorité des cas, touchant moins de trois articulations. L'atteinte de la hanche ou de la coxophémorale, elle est fréquente et redoutable, parce qu'elle met en jeu le pronostic fonctionnel.

Au Maroc, elle est beaucoup plus fréquente et précoce par rapport aux formes européennes. Concernant le syndrome extra-articulaire, les signes généraux sont le plus souvent modérés, faits d'asthénie et d'amaigrissement. Ils sont contemporains des poussées inflammatoires de la

maladie, et ils s'observent plus volontiers dans les formes sévères et des sujets âgés.

Concernant l'atteinte oculaire, on assiste à une vieillite antérieure non granulomateuse, qui survient dans 25 % des cas. Elle est révélatrice dans 2 % des cas. Elle se manifeste par un nœud rouge douloureux avec photophobie et vision floue.

Elle a un risque de récurrence et de séquelles, ce qui peut compromettre le pronostic visuel. De ce fait, il faut informer tout patient atteint de spondyloarthrite de consulter en urgence en cas de nœud rouge douloureux. L'atteinte cardiaque est faite de troubles de conduction et de rythme et d'insuffisance aortique.

Une atteinte rénale faite de néphropathie à dépôt d'immunoglobuline A et surtout d'amylose dans les formes sévères et évoluées. L'atteinte pulmonaire, on peut avoir un syndrome restrictif mis en évidence à l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui est secondaire à une altération de la mécanique thoracorachidienne. La maladie fibroblastique, qui est plus rare, peut être responsable de dyspnée, de toux et d'hémoptyses.

Il ne faut pas oublier l'ostéoporose, qui est une atteinte osseuse secondaire à la spondyloarthrite ankylosante. Des manifestations neurologiques sont possibles, centrales et périphériques. On peut assister à une compression musculaire, secondaire à une subluxation acroïdo-axoïdienne, ou secondaire à des sténoses osseuses par ossification des ligaments longitudinaux postérieurs.

C'est une forme rare. Les formes périphériques seraient secondaires à l'ossification ligamentaire et des articulations interapophysaires postérieures. On peut avoir des radiculgies L5, des névralgies cervicobrachiales et des névralgies intercostales.

Le diagnostic doit être évoqué chez un sujet jeune devant des rachialgies d'horaires inflammatoires, des douleurs fessières, une oligoarthrite asymétrique, une ou deux entésopathies. Concernant les signes biologiques, le syndrome inflammatoire n'est présent que dans 50% des cas. En l'absence de syndrome inflammatoire, on ne peut pas éliminer le diagnostic de spondyloarthrite.

L'HLA-B27 représente un élément d'orientation devant une situation clinique évocatrice. Il trouve sa place devant l'absence de sacroïdes à l'imagerie. Concernant l'imagerie, la radiographie standard, les différences d'incidence qui sont utiles, le grand cliché dorsolombopile biphémorale de face, qu'on appelle l'incidence de TCR, la radiographie de bassin de face en charge, parfois on peut demander l'incidence des sacroiliacs pour dégager les gaz, pour une meilleure interprétation des sacroiliacs, le cliché dorsolombaire face et profil.

Les articulations périphériques vont être radiographiées en fonction de manifestations cliniques. Pour l'atteinte entésique, on peut faire appel à des radiographies de l'arrière-pied, bassin et genou. L'atteinte des sacroiliacs à la radiographie évolue en 4 stades, selon les stades de Forestier, et on peut se les rappeler par ce monde mnémotechnique efficace.

Le stade 1, il s'agit d'un élargissement et flou des berges articulaires. Le stade 2, c'est une irrégularité et érosion des berges articulaires donnant l'aspect en timbre de poste. Le stade 3, c'est une condensation des berges articulaires.

Et puis le dernier stade, c'est l'ankylose. Je vous rappelle que la spondyloarthrite est une maladie ankylosante. Si on regarde cette radiographie de bassin de face, nous avons un aspect normal des sacroiliacs.

Sur cette radiographie, on voit une sacroiliète grade 2 à droite et grade 1 à gauche. Sur cette radiographie de bassin de face, on voit une sacroiliète grade 3 bilatérale. Sur cette radiographie, on trouve un grade 4 bilatéral.

Au niveau du rachis, les différentes lésions qu'on peut rencontrer, ce sont les syndesmophites. Les syndesmophites correspondent à des fines ossifications verticales qui relient les coins vertébraux et dont les formes évoluées donneront un aspect en tiges de baumeaux. La spondylite de Romanus, qui est une spondylite antérieure, c'est une érosion du coin antérieur de chaque vertèbre.

Le squaré, non mis au carré, qui est secondaire à la spondylite antérieure. L'ossification des ligaments, notamment interépineux, interapophysaire, donnera l'aspect en rails de tramway ou en triple rails. On peut assister à des spondylodécites aseptiques.

Et puis l'ankylose, des articulations interapophysaires postérieures, osteoporose et tassements vertébraux. Sur cette radiographie du rachis lombaire de Prophylaxie, on voit une mise au carré de la vertèbre. Des syndesmophites et des lésions de Romanus.

Vous voyez ici les syndesmophites. C'est une ossification verticale. On peut assister à la formation de ponts intervertébraux.

Comme vous voyez ici, c'est une colonne de baumeaux avec une fracture vertébrale attestée par la flèche en regard. Voici une forme de colonne de baumeaux. C'est une ossification de ligaments longitudinales antérieures et postérieures avec des ponts osseux entre les différents vertèbres.

Ici, vous avez une radiographie du rachis lombaire avec une ossification des ligaments interépineux. Vous voyez l'aspect en triple rails. Ici, c'est une radiographie calcaneienne de Prophylaxie mettant en évidence une épine calcaneienne inflammatoire qui a une base d'implantation large.

Un aspect flot qui permet de la différencier d'une épine calcaneienne mécanique où l'épine est fine et bien dessinée. Ici, vous avez une entérophyse, une épine calcaneienne supérieure. On regarde l'insertion de tendons d'Achilles qui est inflammatoire.

Concernant l'IRM, l'IRM des sacroiliacs de rachis, quand on a une radiographie standard qui est

normale, on fait l'IRM. Au niveau des sacrodiacs, elle permet de nous montrer l'œdème osseux secondaire qui est le signe en faveur d'une atteinte relative mal. Et au rachis, elle va nous montrer les spondylites de Romanus, les spondylocytes aseptiques d'Anderson, les signes inflammatoires au niveau des ligaments interépineux interapophysaires et au niveau des articulations interapophysaires postérieures.

Vous voyez sur cet IRM du bassin des sacrodiacs, on voit l'œdème secondaire qui atteste d'une sacrolyte inflammatoire. Au niveau du rachis, on voit les spondylites antérieures et postérieures en forme d'hypersignaux sur les séquences SIR. Pour l'ATDM des sacrodiacs de rachis, il a peu d'intérêt dans le diagnostic précoce, mais elle permet de mettre en évidence les dégâts structureaux, dont sont les formes radiographiques, les érosions, les scléroses, les syndesmophytes et l'ankylose.

Sur ce scanner, vous voyez, c'est un aspect de timbre de poste avec condensation des berges des sacrodiacs. Ici, on voit une spondylite avec une érosion du coin supérieur et inférieur antérieur de la vertèbre L4. L'échographie, c'est un outil à la disposition qui permet de mettre en évidence surtout les anthésites, la coccycle, les thénocynobites et même des cynobites infracliniques et des érosions afradiologiques dans les formes périphériques érosives.

Maintenant, quelles sont les formes cliniques de la maladie? On commence par les arthrites réactionnaires. En fait, ce sont des arthrites aseptiques, c'est-à-dire quand on cherche dans l'aspiration, il n'y a pas de germes là-dedans, mais ils sont déclenchés par des infections à distance, transmises par voie sexuelle ou digestive. La forme typique, c'est le syndrome oculo-urétror-synovial, c'est-à-dire qu'il y a l'arthrite, il y a une urétrite et qu'il y a une conjonctive, l'atteinte oculaire.

C'est le terme syndrome des pissengeres l'oreille rète. Les germes les plus fréquemment retrouvés, l'urétrite et les cervicites non gonococques, clamidia, surtout en coplasme. Les infections digestives, essentiellement Shigella, Myrcina, Salmonella et Campylobacter.

Sur le plan clinique, il s'agit d'une oligoarthrite asymétrique, prédominante au nombre inférieur, et qui évolue moins d'un mois après l'urétrite et ou la diarrhée. C'est pour incriminer les germes en cause. Plus d'un mois, c'est difficile de rattacher l'arthrite à l'infection en cause.

Toujours sur le plan clinique, on aura une conjonctive, une iridocyclite, des syncutanées et muqueuses, ce forme de galamite, d'érosion du palais, au thyrotodermie, palmoplante. Sur le plan biologique, on peut identifier le germe par culture ou sérologie, et la Shigella B24 est retrouvée jusqu'à 80%. La radiologie est normale.

Sur le plan évolutif, il y a trois cas de figure. Dans un tiers des cas, c'est une guérison en un à six mois. Dans un tiers des cas, c'est la récurrence.

Et puis, dans le troisième cas, c'est la chronicité. C'est une forme qui va évoluer vers une

spondyloarthrite en tylosangle. Deuxième cas de figure, deuxième forme clinique, c'est le rhumatisme psoriasique.

Le psoriasis touche 2% de la population générale. Les lésions syncutanées sont souvent retrouvées au niveau des genoux, des coudes, des pieds interficiers, l'ombilique, les angles et le cuir chevelu. Et d'ailleurs, il faut toujours aller chercher dans ces endroits, même si ce n'est pas rapporté par le patient.

5 à 25% des personnes atteintes de psoriasis vont faire un rhumatisme psoriasique. L'atteinte particulière précède le psoriasis dans 10 à 15% des cas, ce qui rend le diagnostic difficile. Sur le plan clinique, c'est un rhumatisme qui est très hétérogène.

Ça peut entraîner une oligoarthrite asymétrique, une polyarthrite asymétrique dans 15 à 20% des cas, traitant en confusion avec une polyarthrite rhumatoïde. Mais le caractère asymétrique, le fait de pouvoir toucher les interphalangènes testales, doit alarmer et orienter vers cette entité. On peut avoir une atteinte axiale comme une vraie spondyloarthrite en tylosangle, et l'atteinte interphalangéenne testale peut être de forme mutuodente, donc très destructrice.

Voici une image de psoriasis glutamine, psoriasis de cuir chevelu. Il fallait le chercher dans ses sites de prédilection. Troisième forme, c'est le rhumatisme des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

C'est essentiellement la maladie de Crohn et la rectocolite pulséro-hémorragique. L'atteinte, là aussi, est polymorphe. Il peut s'agir d'arthrites périphériques, là aussi, prédominantes au niveau des membres inférieurs.

Et ce sont des arthrites souvent rétinées par l'évolutivité de la maladie digestive. C'est-à-dire, le malade fait une poussée intestinale, dont le même temps, il fera une atteinte articulaire. On peut avoir une spondyloarthrite en tylosangle rare, mais cette fois-ci, l'évolution est indépendante de la maladie digestive.

C'est-à-dire, le malade est en poussée articulaire, mais il est en rémission digestive. Et puis, troisième cas de figure, c'est une sacroïde isolée. Quatrième entité est le sapho-syndrome.

C'est le syndrome acné pustulose, hyperostose, ostéite amicrobienne. C'est un syndrome apparenté aux spondyloarthropathies, associant une arthrite sternoclaviculaire au sacroïde, une ostéite amicrobienne isolée et, au satellite des articulations atteintes, une acné sévère avec pustulose palmoplantaire. L'Achela est présent dans 30 % des cas.

Voici des images de pustulose palmoplantaire et d'acné sévère au niveau du visage. Les spondyloarthrites indifférenciées sont de plus en plus fréquentes. Aucun diagnostic est précis.

Il faut rassurer le malade, puisque le plus souvent, ils font de bons pronostics. Concernant le diagnostic différentiel, devant une atteinte sacroïdaque, une atteinte bilatérale doit faire évoquer

une ostéose iliacondensante. C'est une atteinte non inflammatoire et qu'on trouve beaucoup plus chez les femmes, mais on ne s'y parle pas.

Une atteinte sacroïdaque bilatérale, il faut faire attention aux causes myoplasiques, surtout infectieuses, traumatiques ou arthrosiques. Une atteinte vertébrale mécanique, notamment les ostéophiles de l'arthrose. Les ostéophiles, je vous rappelle, ont une orientation horizontale et les syndestimophiles ont une orientation verticale.

L'héperostose vertébrale ankylosante aux maladies de Forestier, les ostéophiles sont beaucoup plus délévérants et le plus souvent latéralisés au niveau du rachis, du côté droit. L'asipose sénile de Schmorl. Concernant l'atteinte périphérique, il faut éliminer les autres rhumatismes inflammatoires chroniques et collagénoses ou connectivites, pour les arthrits rheumatoïdes, les puces.

L'enthésique, devant l'atteinte enthésique, enthésique traumatique, porsionnelle, fragilité tendineuse, métabolique. Dès que la goutte, le diabète, le rhumatisme à hydroxyapathie. Le grand problème, c'est la subromnialgie, ce qui peut donner des atteintes d'allure enthésique diffuse prétendant confusion avec une spondyloarthrite.

Sur cette radiographie, vous voyez une condensation sur le versant iliaque des articulations, avec respect du versant sacré, en rapport avec une ostéose iliaque condensante. Sur la radiographie du rachis, nous avons des becs ostéophiliques horizontaux, mais ils sont exubérants, en rapport avec une hyperostose vertébrale. Si on arrive aux critères diagnostiques, plusieurs critères ont été mis en place, notamment les critères d'amort, qui englobent des signes cliniques, radiologiques, génétiques et sensibilité au traitement, puisque les ANS améliorent de façon spectaculaire les spondyloarthrites.

Et donc, on doit totaliser plus de six points pour pouvoir classer le malade dans le groupe spondyloarthrite. Les critères ASAS sont plus récents pour pouvoir poser le diagnostic à un stade plus précoce. Il y a deux cas de figure.

Soit le malade a des rachis algiques, soit le malade est en attente périodique. Pour le premier cas de figure, où nous avons un patient qui a des rachis algiques plus de trois mois, âgé de moins de 45 ans, soit il a une sacrolyse à l'imagerie, la radiographie standard ou à l'IRM, plus qu'un critère de spondyloarthrite tant qu'il le vente sur la liste que nous avons ici, ou bien un HLA-B27 plus deux critères de SPA pour pouvoir le classer dans les spondyloarthrites. Pour les patients qui ont des symptômes périphériques uniquement avec une arthrite anthésite ou dactylique plus un critère de spondyloarthrite ankylosante à favor l'ovilisme, psoriasisme, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, infection antérieure, HLA-B27 ou sacrolyse à l'imagerie, ou bien deux autres critères de SPA dans l'arthrite, l'anthésite, la dactylique, la RHLG inflammatoire et l'antécédent familial de SPA.

Cela permet de classer le malade dans le groupe spondyloarthrite. Alors maintenant, comment on va évaluer l'activité de la maladie ? Nous avons posé le diagnostic, on s'est basé sur des critères. L'activité, on fait appel à l'OVA douleur, axial-périphérique onculaire, l'OVA fatigue, le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées dans les arthrites périphériques, l'indice anhésique, ou le nombre d'antaises atteintes, le bilan inflammatoire.

Il y a deux scores, le BASDA et l'ASDA. Le BASDA, c'est le BAS, Ankylosing Spondylitis Activity Index. Donc, c'est un indice d'activité et on part d'une maladie active quand il est de plus de 4. C'est un questionnaire qu'on pose aux patients qui va répondre et le total, quand il est de plus de 4, on est en présence d'une maladie active.

L'ASDA, c'est l'Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score. Alors, il contient la douleur rachidienne, la durée du déroulage matinal, l'OVA global du patient, les douleurs et le gonflement périphérique. Tout ça, ils sont cotés entre 0 à 10.

On ajoute la CRT sur un logiciel qui est disponible sur le net. Donc, on va avoir un chiffre pour pouvoir classer notre malade. Donc, un malade, il est inactif quand son ASDA est inférieur à 1,3.

Entre 1,3 et 2,1, on parle d'une activité modérée. Entre 2,1 et 3,5, on parle d'une activité forte. C'est une très forte activité quand l'ASDA est supérieur à 3,5.

Maintenant, le traitement. Les objectifs du traitement, c'est de réduire, de traiter ou de prévenir l'inflammation, la douleur, l'arrêt et l'ankylose et d'alimenter les informations, bien sûr. L'éducation et l'information du patient est une étape fondamentale pour pouvoir intégrer le patient dans sa propre prise en charge.

Concernant le traitement symptomatique, il fait appel aux antalgiques qui ne relaxent qu'un complément des A&S. Elles permettent de faciliter la rééducation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils sont efficaces à 70 %. Que ce soit sur les douleurs, l'arrêt et l'arrêt.

Ils sont rapidement efficaces et la rechute est au bout de 48 heures après l'arrêt. Donc c'est un test thérapeutique et d'ailleurs il figure dans les critères des diagnostics de la mort. Il faut donner une dose optimale, préférer la prise nocturne d'une forme à libération prolongée et puis ils peuvent aussi être adaptés au moment douloureux de la journée.

La sensibilité, il faut savoir que la sensibilité aux différentes familles est variable d'une personne à l'autre. C'est la variabilité inter-individuelle et donc essayer trois ANS au moins avant de conclure à l'échec. Les traitements locaux, ils sont proposés en cas d'arthrite ou d'enthésopathie rebelles aux traitements généraux tels qu'une infiltration de corticoïdes pour une coccyx par exemple, pour une enthésopathie, les synovites isotopiques et puis on peut proposer aussi de la physiothérapie.

Concernant les traitements de fangs, les traitements de fangs classiques, ici c'est en fonction de

la forme clinique. Si nous avons une spondylarthrite ankylosante avec atteinte périphérique rebelle aux traitements symptomatiques, on privilégie la phallothérapie. Pour le rhumatisme psoriasique, on va beaucoup plus privilégier le méthotrexate.

Il faut savoir que ces traitements de fangs classiques n'ont aucun effet sur l'enthésie ou sur l'atteinte feldirachidienne. C'est uniquement pour les formes périphériques. La biothérapie, les entités NF-alpha, l'anti-LDF, l'anti-L23, où leur indication émane des connaissances physiopathologiques, ils sont efficaces en matière de traitement de fangs.

Ils sont indiqués, pas d'ombrelle, mais en cas d'échec d'au moins trois ANF pendant trois mois, échec des gestes locaux, échec des traitements classiques. Les traitements physiques, ils visent à prévenir les déformations rachidiennes. Et puis, devant une coccite évoluée, devant les grandes cifoses irréductibles, un traitement chirurgical peut être proposé.

Donc, en conclusion, la spondylarthrite ankylose, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique avec un potentiel destructeur et ankylosant chez un sujet jeune. On sait que l'inflammation évolue vers l'ankylose. Donc, c'est la nécessité de faire un diagnostic précoce et de prendre en charge précocement le malade avant l'installation de l'arrière.